Клинические рекомендации

Потеря слуха, вызванная шумом

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H83.3** — Шумовые эффекты внутреннего уха **Z57.0** — Неблагоприятное воздействие производственного шума
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.03.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Национальная медицинская ассоциация сурдологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/609_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика **6**

3.1 Жалобы и анамнез 6

3.2 Осмотр и консультации специалистов 7

3.3 Клинические и биохимические исследования крови и мочи 7

3.4 Электрокардиография 8

3.5 Условия аудиометрического исследования 8

3.6 Камертональные пробы 8

3.7 Тональная пороговая аудиометрия 8

3.8 Надпороговые тесты 8

3.9 Импедансометрия 8

3.10 Вызванная отоакустическая эмиссия 9

3.11 Слуховые вызванные потенциалы 9

3.12 Исследование вестибулярной функции 9

3.13 Лучевая и ультразвуковая диагностика 9

3.14 Иные диагностические исследования 9

3.15 Предварительный и заключительный диагноз 10

4. Лечение **10**

4.1 Медикаментозное лечение 10

4.2 Физические (нелекарственные) методы 11
4.3 Слухопротезирование 12
4.4 Иное лечение 12
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12
5.1 Организация медицинской помощи 12
5.2 Реабилитация 12
5.3 Первичная профилактика 13
5.4 Диспансерное наблюдение 14
5.5 Факторы, влияющие на исход 14
6. Источник и актуальность 15
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 15

1. Основные положения

- Профессиональная тугоухость: медленно развивающаяся хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость от производственного шума выше предельно допустимого уровня — **80 дБА**.
- Типичная аудиограмма: двусторонний симметричный «провал» **на 4000 Гц** (реже 3000 Гц) с подъёмом на 8000 Гц, без костно-воздушного разрыва; пороги на разговорных частотах ниже, чем на высоких, **не менее чем на 15 дБ**.
- Предварительный диагноз устанавливает оториноларинголог на периодическом медосмотре или при обращении, заключительный устанавливает только центр профпатологии.
- Подозрение на профессиональную тугоухость (двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость с типичной аудиограммой):
  1. шум на рабочем месте **до 90 дБА**: стаж **15 лет и более**;
  2. шум **более 90 дБА**: стаж **10 лет и более**;
  3. после предварительного диагноза работника направляют в центр профпатологии **в течение 30 дней**.
- Профпригодность по заключительному диагнозу:
  1. признаки воздействия шума (Z57.0): трудоспособен без ограничений;
  2. I «А» степень: трудоспособен в профессии, наблюдение в центре профпатологии **раз в год**;
  3. I «Б» степень: трудоспособен, наблюдение **2 раза в год**;
  4. II степень и выше: работа в шуме **выше 80 дБА** противопоказана, направление на медико-социальную экспертизу.
- Лечение эффективно только на ранних стадиях: при признаках воздействия шума на орган слуха (Z57.0) и I степени потери слуха. При II–III степени медикаментозное лечение малоэффективно, а при III степени и трудностях общения подбирают слуховой аппарат.
- Основу составляет профилактика: средства индивидуальной защиты органа слуха, «защита временем», медосмотры и группы диспансерного наблюдения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Потерей слуха, вызванной шумом, называют медленно развивающееся хроническое двустороннее нарушение слуха, причиной которого является производственный шум выше предельно допустимого уровня (**80 дБА**).

Поражается звуковоспринимающий отдел слухового анализатора, то есть нейроэпителий внутреннего уха; клинически это проявляется хронической двусторонней сенсоневральной тугоухостью.

Акустическая травма в этих КР не рассматривается: её тоже кодируют H83.3, но оформляют как несчастный случай на производстве.

2.2 Этиология и патогенез

Причиной является производственный шум выше гигиенических нормативов. Шум **до 90 дБА** учащает временное смещение порогов слуха после смены: это индикатор риска, а не начало профессиональной патологии; при продолжении воздействия возможен переход в постоянное смещение.

Усугубляют действие шума

1. напряжённость и тяжесть труда;
2. нагревающий микроклимат;
3. заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и иммунной систем.

Единой теории патогенеза нет. Морфологическим субстратом служит дегенерация наружных и внутренних волосковых клеток кортиева органа, причём процесс носит восходящий характер. Главной причиной гибели клеток считают оксидативный стресс: апоптоз наружных волосковых клеток проявляется временным повышением порогов, а некроз — постоянным смещением порогов и тугоухостью.

Основным звеном патогенеза являются сосудистые расстройства: снижение кровенаполнения в вертебробазилярной системе, ангиоспазм, затруднение венозного оттока. Лабиринтная артерия является концевой и не имеет коллатералей, а рецепторы улитки очень чувствительны к гипоксии.

Шум служит дополнительным фактором риска артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и нарушений вегетативной регуляции; как правило, эти экстраауральные нарушения предшествуют поражению слуха.

На большинстве производств шум действует вместе с вибрацией, инфразвуком, нервно-эмоциональным и физическим напряжением, нагревающим микроклиматом, токсическими веществами.

2.3 Классификация

Классификация потери слуха, вызванной шумом

Степень	Средний порог по воздуху на 500, 1000, 2000, 4000 Гц, дБ
Признаки воздействия шума на орган слуха	11–25
I степень (I «А», I «Б»)	26–40
II степень	41–55
III степень	56–70
IV степень	71–90

Подгруппы I степени

1. I «А»: нет экстраауральной патологии;
2. I «Б»: гипертоническая болезнь 2 степени и выше, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга 2 степени и выше.

Подгруппы нужны для выбора лечения и чтобы предупредить работника с I «Б» о повышенном риске при продолжении работы в шуме.

«Коррекцию на возраст» не применяют: при потере на высоких частотах **более 45–50 дБ** у пожилых нельзя разграничить шум и старение.

Возрастная инволюция слуха начинается **после 35–37 лет** и к 40–49 годам даёт на речевых частотах **до 10 дБ**. Её учитывают только до стадии признаков воздействия шума (Z57.0); при порогах выше параметров пресбиакузиса степень считают от аудиометрического нуля.

2.4 Клиническая картина

Развивается медленно, обычно **10–14 лет**; первые донозологические изменения на аудиограмме возможны **при стаже 5 лет**.

Жалобы по мере развития

1. сначала появляются экстраауральные жалобы: нарушение сна, раздражительность, головная боль;
2. позже присоединяются ухудшение разборчивости речи, особенно в шуме, шум в ушах и снижение слуха.

Отоскопия

1. барабанная перепонка втянута, мутная;
2. инъекция сосудов по рукоятке молоточка;
3. световой конус укорочен.

Такая картина чаще наблюдается при сочетании шума и вибрации.

Развитие изменений на аудиограмме

1. сначала повышение порогов **на 12, 14, 16 кГц**;
2. затем «провал» **на 4000 Гц** (реже 3000 Гц) с подъёмом на 8000 Гц — на восприятие речи не влияет, выявляется только аудиометрией;
3. при продолжении шума «провал» расширяется на соседние частоты; жалоб на слух ещё нет.

Костно-воздушного разрыва нет.

Отличия от пресбиакузиса

1. пологая нисходящая кривая, наибольшее повышение порога на 4000 Гц;
2. средний порог на 500, 1000, 2000 Гц всегда ниже, чем на 3000, 4000, 6000 Гц, разница **не менее 15 дБ**;
3. пороги на 3000, 4000, 6000 Гц всегда выше, чем на 8000 Гц;
4. шум обычно не даёт потери **более 75 дБ** на высоких и **более 40 дБ** на разговорных частотах.

У работников **старше 50–55 лет** «провал» менее выражен; без прежних аудиограмм начальные признаки трудно отличить от пресбиакузиса. При сочетании шума и возраста вместо «провала» формируется «впадина».

Типичные клинико-аудиологические признаки

1. постепенное повышение порогов по типу нарушения звуковосприятия в течение нескольких лет, **не менее 5**;
2. двусторонний процесс;
3. нет костно-воздушного разрыва;
4. нисходящая кривая с «провалом» на 4000 или 3000 Гц;
5. постепенное повышение порогов на 1000 и 2000 или 3000 Гц;
6. при стаже **20 лет и более** — значительнее на речевых частотах, выраженные «провалы» на 2000 и 4000 Гц.

Самые ранние изменения выявляет вызванная отоакустическая эмиссия. Отсутствие задержанной ОАЭ **более чем в 4 частотных полосах** при нормальных тональных порогах является неблагоприятным признаком и служит показанием к динамическому наблюдению и реабилитации.

Для скрининга задержанная ОАЭ предпочтительнее ОАЭ на частоте продукта искажения.

Надпороговые и объективные тесты

1. положительный феномен ускоренного нарастания громкости, дифференциальный порог 0,6–0,4 дБ в начале; 1,5–3 дБ — при нарастании тугоухости;
2. показатели теста Si-Si растут с тугоухостью, до 100% при повышении порога **на 40 дБ**;
3. слуховое поле сужено до 90 дБ, возможен гиперакузис;
4. повышение порогов на 16, 14, 12 кГц в расширенном диапазоне;
5. тимпанограмма тип «А», акустический рефлекс сохранён (60–70 дБ), при высокой степени тугоухости не вызывается;
6. амплитуда задержанной ОАЭ снижена, выпадают частоты (прежде всего 4000 или 3000 Гц); при порогах **более 30 дБ** ОАЭ не регистрируется.

Экстрааурaльные проявления

1. головная боль, раздражительность, утомляемость, нарушение сна;
2. шум в ушах, головокружение с потемнением в глазах;
3. боль в области сердца, сердцебиение;
4. при осмотре: изменение сухожильно-периостальных рефлексов, тремор пальцев, стойкий дермографизм, акроцианоз, потливость, неустойчивость в позе Ромберга.

Шум вместе с вибрацией раздражает вестибулярный анализатор: «уплывание глаз», диссоциация вестибуло-окулярных реакций при калорической и вращательной пробах. Для «шумовых» профессий характерно понижение вестибулярной возбудимости.

---

3. Диагностика

Два этапа

1. предварительный диагноз — на периодическом медосмотре или при любом обращении;
2. заключительный — только учреждение профпатологии с лицензией по профпатологии, экспертизе связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности.

Критерии диагноза

1. жалобы: постепенное снижение слуха, больше на высоких частотах, низкочастотный шум в обоих ушах или в голове, хуже разборчивость речи в шуме;
2. в анамнезе нет сердечно-сосудистых болезней, церебрального атеросклероза, остеохондроза, нарушений липидного обмена, сифилиса, сахарного диабета, болезней среднего уха и носоглотки, травм головы, наследственной тугоухости, лечения аминогликозидами;
3. стаж в шуме **10 лет и более**, уровень шума **выше 80 дБА**.

При осмотре

1. пальпация уха и сосцевидного отростка безболезненна;
2. слуховой проход свободен;
3. барабанная перепонка чаще матовая, слегка втянута, световой конус укорочен, сосуды по рукоятке молоточка инъецированы.

Кровь в норме, липидный профиль нарушен.

Инструментально: двусторонняя симметричная нисходящая кривая с «провалом» на 4000 Гц, без костно-воздушного разрыва; надпороговые тесты — как в разделе «Клиническая картина». Отсутствие задержанной ОАЭ **на 4000 Гц** — ранний признак воздействия шума.

3.1 Жалобы и анамнез

Уточняют характер работы, уровень шума на рабочем месте и стаж в нём, все прежние профессии и вредные факторы, сопутствующие болезни.

Характерно для шумовой тугоухости

1. нет недавних острых заболеваний, в том числе COVID-19;
2. раздражительность, нарушение сна;
3. шум в обоих ушах или в голове раньше снижения слуха;
4. нет хронических болезней среднего уха, гипертензии, диабета, нарушений липидного обмена;
5. нет шумных увлечений: громкой музыки, стрельбы;
6. нет тугоухости у близких родственников;
7. постепенное снижение слуха;
8. «шумоопасная» профессия, стаж в шуме выше допустимого **более 8–10 лет**.

3.2 Осмотр и консультации специалистов

Всех работающих в шуме выше допустимого уровня на медосмотре осматривает оториноларинголог, чтобы выявить нарушения слуха и противопоказания к работе. При типичных жалобах и аудиограмме и стаже **10 лет и более** он вправе установить предварительный диагноз профессиональной тугоухости.

Осматривают наружное ухо и сосцевидный отросток.

Обязателен и осмотр верхних дыхательных путей, поскольку болезни носа и околоносовых пазух могут быть дополнительной причиной снижения слуха.

При подозрении на шумовую тугоухость оториноларинголог повторно осматривает пациента в учреждении профпатологии, чтобы установить заключительный диагноз, определить профпригодность и группу диспансерного наблюдения и разработать индивидуальную программу реабилитации слуха.

При углублённом обследовании в стационаре профпатологии — ежедневный осмотр оториноларинголога.

Консультация сурдолога-оториноларинголога

1. первичная консультация: при затруднительной дифференциальной диагностике;
2. повторная консультация: для углублённого обследования слуха, установления заключительного диагноза и составления программы реабилитации, в том числе слухопротезирования.

Консультации терапевта и невролога

1. первичные консультации на предварительном и периодических медосмотрах: оценка экстраауральных эффектов шума и противопоказаний к работе в шуме, лечение сопутствующих болезней;
2. повторные консультации: при установлении заключительного диагноза.

Невролог первично оценивает влияние шума на нервную систему и противопоказания к работе в шуме.

Повторный осмотр невролога проводится при установлении заключительного диагноза.

Задачи первичной консультации профпатолога по результатам медосмотра

1. противопоказания к работе в шуме;
2. возможность предварительного диагноза;
3. запрос санитарно-гигиенической характеристики условий труда;
4. направление в центр профпатологии.

По результатам повторной консультации устанавливают заключительный диагноз, определяют профпригодность и диспансерную группу.

Повторный приём профпатолога проводится в учреждении профпатологии при решении о заключительном диагнозе.

3.3 Клинические и биохимические исследования крови и мочи

Показания

1. все работники «шумоопасных» профессий и пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Исследования общеклинической программы

1. развёрнутый общий анализ крови;
2. общий анализ мочи;
3. биохимический общетерапевтический анализ крови;
4. липидный профиль (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности): значим для патогенеза и выявляет дополнительные экстраауральные эффекты шума.

3.4 Электрокардиография

Показания

1. все работники «шумоопасных» профессий;
2. все пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Исследование входит в программу общеклинического обследования на периодическом медосмотре и в учреждении профпатологии.

3.5 Условия аудиометрического исследования

Аудиометрию работникам в шуме проводят **не ранее чем через 14 часов** после прекращения контакта с шумом, чтобы исключить временное смещение порогов.

3.6 Камертональные пробы

Показания

1. работники «шумоопасных» профессий с жалобами на снижение слуха.

Пробы Вебера и Ринне дают ориентировочную оценку слуха и разграничивают нарушение звукопроведения и звуковосприятия.

3.7 Тональная пороговая аудиометрия

Показания

1. все работники «шумоопасных» профессий: воздушное и костное проведение в конвенциальном диапазоне.

Основной метод диагностики и дифференциальной диагностики, выявляет ранние сдвиги порогов. Типичная картина описана в разделе «Клиническая картина».

Показания к аудиометрии в расширенном диапазоне частот

1. работники «шумоопасных» профессий с жалобами на снижение слуха;
2. пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Выявляет самые ранние изменения **на 12, 14, 16 кГц**, не видимые другими методами.

3.8 Надпороговые тесты

Показания

1. все пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Проба Люшера, порог дискомфорта и тест Si-Si углубляют оценку слуховой функции и уточняют уровень поражения.

Речевая аудиометрия выполняется по показаниям, для профпригодности по отраслевым требованиям, прежде всего в гражданской авиации.

3.9 Импедансометрия

Показания

1. все пациенты с потерей слуха, вызванной шумом;
2. экспертиза связи заболевания с профессией, при которой исследование обязательно.

Цель: дифференциальная диагностика и определение уровня поражения слухового анализатора.

3.10 Вызванная отоакустическая эмиссия

Показания

1. все пациенты с потерей слуха, вызванной шумом.

Цель: выявление самых ранних нарушений, подтверждение степени, исключение аггравации и симуляции. Изменения появляются прежде всего в полосе 4 кГц.

Диагностические признаки

1. отсутствие ОАЭ **более чем в 4 частотных полосах**: показание к расширенному аудиологическому обследованию;
2. подавление ОАЭ **на 4 кГц** при нормальных тональных порогах: неблагоприятный признак, показание к динамическому наблюдению.

Задержанная ОАЭ предпочтительна для скрининга работающих в шуме.

ОАЭ на частоте продукта искажения уточняет степень повышения порогов и рельеф аудиограммы при экспертизе.

3.11 Слуховые вызванные потенциалы

Показания

1. сложные и спорные случаи диагностики.

Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы являются основным методом объективного определения порогов и исключения аггравации и симуляции.

В тех же случаях для объективизации порогов применяют ASSR-тест (вызванные ответы мозга на постоянные модулированные тоны).

3.12 Исследование вестибулярной функции

Показания

1. жалобы на головокружение и шаткость.

На медосмотре оценивают спонтанный нистагм, при возможности выполняют вестибулометрию.

3.13 Лучевая и ультразвуковая диагностика

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий выполняют для оценки кровоснабжения внутреннего уха.

Рентгенография шейного отдела позвоночника позволяет выявить причины нарушения кровообращения в вертебробазилярной области.

По рентгенографии околоносовых пазух оценивают состояние пазух и слуховой трубы как сопутствующих причин снижения слуха.

КТ височных костей выполняют для дифференциальной и топической диагностики по согласованию с рентгенологом, с контрастом или без него. Односторонние нарушения могут скрывать двусторонний процесс (например, нейрофиброматоз II типа).

МРТ, в том числе с контрастом, выполняют для исследования внутренних слуховых проходов, мостомозжечковых углов и задней черепной ямки.

Лечение шума в ушах и тугоухости без дифференциальной диагностики недопустимо: например, при невриноме слухового нерва витамины, ноотропы и физиотерапия могут ускорить рост опухоли.

3.14 Иные диагностические исследования

Рефлексотерапевт определяет показания и противопоказания к лечению методами рефлексотерапии.

Физиотерапевт определяет показания и противопоказания к физиотерапевтическому лечению.

3.15 Предварительный и заключительный диагноз

Критерии подозрения на профессиональную тугоухость

Двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость с типичной аудиограммой при условии:

1. шум на рабочем месте **до 90 дБА** — стаж **15 лет и более**;
2. шум **более 90 дБА** — стаж **10 лет и более**.

При признаках воздействия шума (Z57.0) на медосмотре ограничений профпригодности нет. Работника включают в группу повышенного риска и разрабатывают ему индивидуальную программу реабилитации слуха. Это донозологическое состояние, а не заболевание.

После предварительного диагноза работника **в течение 30 дней** направляют в центр профпатологии и подают извещение в Роспотребнадзор.

Связь с профессией после прекращения работы в шуме рассматривают, только если тугоухость документально подтверждена в период работы; появление или прогрессирование тугоухости после прекращения контакта с шумом основанием не является. Перерывы в стаже снижают вероятность прогрессирования.

Формулировки заключительного диагноза и профпригодность

1. признаки воздействия шума (Z57.0): трудоспособен без ограничений;
2. I «А» степень: трудоспособен в профессии при наблюдении в центре профпатологии **раз в год**, разработана программа реабилитации слуха;
3. I «Б» степень: трудоспособен при наблюдении **2 раза в год**, предупреждён о риске;
4. II степень и выше: работа в шуме **выше 80 дБА** противопоказана, направление на медико-социальную экспертизу.

---

4. Лечение

Лечение эффективно только в самых начальных стадиях — «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха, и только при устранении шума. Лечение такое же, как при нейросенсорной тугоухости непрофессионального генеза: микроциркуляция внутреннего уха, мозговая гемодинамика, оксигенация.

Курсы **не менее 10 дней**, **не реже 2 раз в год**; в группе риска — раз в год.

Работникам «шумоопасных» профессий назначают охранительный слуховой режим.

4.1 Медикаментозное лечение

Шум в ушах и сенсоневральная тугоухость: «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха

1. ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции;
2. периферические вазодилататоры;
3. ноотропные препараты;
4. препараты для устранения головокружения;
5. психоаналептики.

Применение вне инструкции при H83.3 допускается распоряжением Правительства № 1180-р. При II и III степени медикаментозное лечение малоэффективно.

При шуме в ушах, признаках воздействия шума (Z57.0) или I степени потери слуха применяют витамины группы B в дозах по инструкции.

Поддерживающие курсы проводят по индивидуальным показаниям с учётом соматических болезней, совместно с профильными специалистами.

4.2 Физические (нелекарственные) методы

Немедикаментозные методы значительно повышают эффективность лекарств. Все они применяются при отсутствии противопоказаний, при шуме в ушах и потере слуха от шума.

Метод	Показания
рефлексотерапия	Z57.0 и I степень
электропунктура	Z57.0 и I степень
лазеропунктура	Z57.0 и I степень
транскраниальная электростимуляция	любая степень
магнитотерапия на шейный отдел позвоночника и сосцевидные отростки	I–II степень
УВЧ на шейный отдел позвоночника и сосцевидные отростки (УДД 4)	любая степень
дарсонвализация органа слуха	любая степень
эндауральная дарсонвализация (УДД 4)	любая степень
внутриушной электрофорез лекарственных препаратов	любая степень
плазмаферез	любая степень
лекарственный ультрафонофорез	любая степень
электрофорез синусоидальными модулированными токами (УДД 4)	шум в ушах и потеря слуха
общий медицинский массаж	любая степень
медицинский массаж шеи	любая степень
массаж воротниковой области	любая степень
гипербарическая оксигенация	начальные нарушения, усиление базисной терапии
заушные блокады с лекарственными препаратами	Z57.0 и I степень, шум в ушах и в голове

4.3 Слухопротезирование

При необратимой потере слуха III степени и трудностях общения подбирают слуховой аппарат (цифровой, бинауурально или моноурально) вместе с лечебно-реабилитационными мероприятиями.

Хирургическое лечение при сенсоневральной тугоухости, в том числе шумовой, не показано.

4.4 Иное лечение

Лечебно-оздоровительный режим направлен на уменьшение стресса и экстраауральных эффектов шума.

Диетическое питание индивидуально, с учётом нарушений липидного обмена; без иных показаний — стол № 10 или 15.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация медицинской помощи

Порядок установления диагноза профессиональной тугоухости

1. предварительный диагноз устанавливает оториноларинголог или сурдолог любой медицинской организации амбулаторно;
2. **в течение суток** пациента направляют к профпатологу по месту жительства;
3. профпатолог подтверждает диагноз и **в 3-дневный срок** направляет извещение в Роспотребнадзор;
4. Роспотребнадзор **в 2-недельный срок** составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда;
5. профпатолог **в месячный срок** направляет пациента в учреждение профпатологии.

Документы при направлении в учреждение профпатологии

1. копия трудовой книжки;
2. выписки предварительного и периодических медосмотров;
3. результаты обследований;
4. копии аудиограмм за весь период работы в шуме;
5. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.

Все документы заверяются печатями.

Заключительный диагноз устанавливает врачебная комиссия учреждения профпатологии — амбулаторно или после обследования в стационаре; извещение **в 3-дневный срок** направляют в Роспотребнадзор, работодателю, страховщику и в направившую организацию.

При предварительном диагнозе показаний к госпитализации нет. Госпитализация в учреждение профпатологии проводится для углублённого обследования перед установлением заключительного диагноза.

Выписка осуществляется после решения вопроса об установлении или отсутствии заключительного диагноза.

5.2 Реабилитация

Всем работникам «шумоопасных» профессий проводят краткое профилактическое консультирование: причины и профилактика потери слуха, средства индивидуальной защиты органа слуха, здоровый образ жизни.

Медицинская реабилитация при любой степени потери слуха включает разработку индивидуальной программы реабилитации слуха.

Санаторно-курортное лечение рекомендуется всем работающим в шуме, в том числе без нарушений слуха. Его проводят в период отпуска **не реже раза в год** в санатории, дневном стационаре, профилактории или доме отдыха.

Объём лечения определяют

1. терапевт, невролог, хирург;
2. медицинский психолог или психиатр;
3. офтальмолог, оториноларинголог.

Программы оздоровления составляют с учётом шума и сопутствующих факторов, класса условий труда, здоровья работника, формы и степени тугоухости.

У всех прошедших санаторно-курортное лечение оценивают его результаты. Результатом реабилитации считают устранение проявлений тугоухости или значительное улучшение слуха, положительную динамику аудиометрии, улучшение самочувствия.

Эффективность оздоровления оценивают по медико-социальным и экономическим показателям: заболеваемость с временной нетрудоспособностью, новые случаи профессиональной тугоухости, число профнепригодных и инвалидов.

Лечебный массаж шеи и воротниковой области проводят ежедневно, курс — **до 10 процедур**.

Слуховой тренинг в шлеме виртуальной реальности применяют дополнительно при лёгкой сенсоневральной тугоухости и скрытой потере слуха: ежедневно в течение **7 дней**, занятие длится **15 минут** с паузой 2 минуты.

Вестибулярные тренировки, в том числе с применением виртуальной реальности, проводят ежедневно или через день **по 30 минут**, курс — **20 процедур**.

5.3 Первичная профилактика

Технические меры

1. специальная оценка условий труда;
2. снижение шума и усиливающих его факторов (вибрации, напряжения, вынужденной позы) до нормативов;
3. замена шумных технологий;
4. коллективная защита: шумозащитные панели, перегородки, потолки.

Средства индивидуальной защиты органа слуха

1. противошумные наушники;
2. вкладыши («беруши»);
3. шлемы и костюмы.

Средства индивидуальной защиты применяют, если коллективная защита не снижает шум до нормы; работодатель предоставляет их бесплатно.

«Защита временем»

1. 10-минутные регламентированные перерывы с подменой: при высокой нагрузке — **каждые 2 часа**, при средней — **не реже чем каждые 4 часа**;
2. работа с шумом или вибрацией **не более 2/3 смены**;
3. микропаузы в шумных операциях;
4. смена «шумоопасной» профессии на «шумобезопасную» в комплексной бригаде.

Для обоснования мер первичной профилактики рассчитывают групповой избыточный риск потери слуха от шума (приложение Г1 КР).

Вспомогательно применяют производственную гимнастику, ультрафиолетовое облучение, витамины и сбалансированное питание.

Отдых в комнатах психологической разгрузки и домах отдыха снимает негативные эффекты хронического стресса от воздействия шума.

Медицинский отбор в профессию проводят на предварительном и периодических медосмотрах по приказу Минздрава № 29н.

5.4 Диспансерное наблюдение

Периодические медосмотры представляют собой диспансеризацию трудовых коллективов; по их результатам выделяют группы динамического наблюдения.

Группы динамического наблюдения

Группа	Кто входит	Наблюдение
I «А»	практически здоровые: шум **не выше 90 дБА** при любом стаже или **выше 90 дБА** при стаже **до 10 лет**	медосмотр раз в год, профилактика, подбор и использование средств защиты
I «Б»	практически здоровые: шум **выше 90 дБА**, стаж **более 10 лет**	как I «А» + массаж воротниковой зоны 2 раза в год, рефлексотерапия раз в год
II	признаки воздействия шума на орган слуха (Z57.0)	как I «Б» + гипербарическая оксигенация, лекарства, санаторно-курортное лечение раз в год
III «А»	потеря слуха от шума I «А» степени	трудоспособен; центр профпатологии раз в год, программа реабилитации, лекарства и немедикаментозное лечение, санаторий раз в год
III «Б»	I «Б» степень: в сочетании с гипертонической болезнью или хронической ишемией мозга 2 степени и выше	как III «А» + лечение сосудистой патологии; курс и центр профпатологии 2 раза в год
III «В»	II степень и выше (H83.3, H90.3) любой этиологии	непригоден к работе в шуме, медико-социальная экспертиза; наблюдение по месту жительства 2 раза в год

При хронической сенсоневральной тугоухости любой степени составляется индивидуальная программа реабилитации слуха; её разрабатывает и контролирует оториноларинголог или сурдолог-оториноларинголог.

5.5 Факторы, влияющие на исход

Сердечно-сосудистые болезни и нарушения липидного обмена усиливают действие шума: тугоухость развивается быстрее, пороги на высоких частотах выше, типичные аудиологические признаки стираются. Шум может вызвать соматизированное депрессивное расстройство.

Усиливают вред шума

1. стрельба, охота, громкая музыка, особенно в наушниках;
2. алкоголь, курение, наркотики;
3. лечение аминогликозидами в анамнезе;
4. глухота у близких родственников;
5. травмы головы.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Потеря слуха, вызванная шумом»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 15.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее марта 2027 года
Код в рубрикаторе	609_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Национальная медицинская ассоциация сурдологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Липиды противоречат друг другу: в разделе 1.2 при действии шума снижены ЛПВП, в критериях диагноза (раздел 2) — «повышены» общий холестерин, ЛПВП и ЛПНП.
- Стаж для подозрения на профессиональную тугоухость указан по-разному: «10 и более лет» (раздел 2), «более 8–10 лет» (раздел 2.1), 15 лет при шуме до 90 дБА и 10 лет при шуме выше 90 дБА (приложение Б).
- Для группы III «А» немедикаментозное лечение отсылает к разделу 3.2, но там хирургическое лечение (не рекомендуется); немедикаментозные методы — раздел 3.1.2.
- PDF в рубрикаторе — распознанный скан: в цитатах журнала сверки встречаются ошибки распознавания (например, «257.0» вместо Z57.0, «81-81» вместо Si-Si). Цифры таблиц сверены по изображениям страниц.